

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	急性腎衰竭 Acute Renal Failure；ARF				
	編號	制定者	核准者	公布日期	
	A31000-Q03-W-E04	MI 賴美玉	吳姿蓉	111 年 05 月 31 日	97 年 05 月 31 日
	護理部	劉俞均		修正日期	111 年 11 月 08 日
版本/總頁數	第 3.7 版/8 頁	審查者		檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解急性腎衰竭的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

係指腎臟在短時間內失去維持體內環境恆定的能力，是因腎臟實質損傷，循環衰竭導致急性尿液形成障礙所引起的，或泌尿道阻塞導致排尿障礙所引起的。

（二）臨床分期

- 1.少尿期：會出現排尿量減少的情形（每天尿量少於 100cc），持續 10-14 天。
- 2.利尿期：在此期由於腎臟有某種程度的復原，可以開始排尿，每日的尿量會增加，每天的排尿量約為 1-2 公升，甚至可多達 4-5 公升。此期的持續時間為 10-14 天。
- 3.恢復期：腎功能逐漸的恢復，約需 3~12 個月才能恢復正常，也有可能留下輕微至中度的腎臟損傷。

（三）臨床症狀

- 1.體液及電解質不平衡。
- 2.酸鹼平衡障礙。

主題名稱	急性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/8

3.代謝廢物的存留。

4.腸胃道出血。

5.貧血。

6.感染。

(四) 常見檢查

1. 內科病史：詢問家族史、過去是否有引起腎臟損壞的致病因素，如腎前、腎臟及腎後因素。
2. 身體評估：確定是否水腫、泌尿道阻塞、嚴重尿毒症症狀等。
3. 實驗室檢查：包括尿液分析、血清生化檢查，如血清肌酸酐和血中尿素氮及血清電解質等。
4. 非侵入性放射線檢查：如腹部 X 光攝影、超音波檢查、電腦斷層檢查。
5. 腎臟穿刺檢查：因會有出血的高危險性存在，除非其他檢查沒有發現且症狀持續三週以上才做。

(五) 常見治療

以內科治療來預防腎臟進一步損壞，促其恢復腎功能，並預防合併症。

1. 液體的攝取應密切監測：一般補充是以 24 小時內所有喪失量，如：尿液、腹瀉、嘔吐和出血，再加上 500cc 無感性蒸發(Insensible losses)做為隔天水分攝取量的參考。
2. 利尿劑的使用：以能夠增加鈣排泄的利尿劑和滲透性利尿劑，如 Lasix、Mannitol，來增加腎臟的血流及過濾率。
3. 密切監測血中鉀含量，可使用 50% Glucose + Insulin 緩解高血鉀。
4. 腸胃道出血的控制：制酸劑的使用、由胃內視鏡找出出血點來止血、以上方法無效，則執行外科手術。
5. 貧血的治療：當病人血色素過低或貧血症狀，可給予輸濃縮紅血球(PRBC)，若輸全血會造成水分負荷過重。
6. 飲食方面：攝取高熱量、低蛋白、低鈉、低鉀、低磷飲食，蛋白質之限制為首

主題名稱	急性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/8

要，以減少代謝廢物產生。

7. 感染治療：嚴密遵守無菌操作，盡可能移除體內導管；使用抗生素及抗黴菌藥物，需考慮到腎臟排泄功能及蓄積時間，依 Cr 適度減量會拉長使用間距。
8. 透析治療：若採上述治療仍出現充血性心衰竭、肺水腫、高血鉀、酸中毒，甚至昏迷時須採用透析治療。

（六）護理問題

1. 體液容積太多／腎衰竭無法過濾正常的體液及電解質有關。
2. 焦慮感受／自我概念受到威脅與不確定感有關情形。

（七）護理措施

1. 體液容積太多／與腎衰竭無法過濾正常的體液及電解質有關。
 - (1)每天量體重。
 - (2)每天量腹圍。
 - (3)記錄輸出入量情形。
 - (4)密切觀察生命徵象。
 - (5)評估水腫情形，水腫程度（是否侵犯到軀幹）、水腫大小（用正常的四肢作對照）、水腫的硬度（用手指壓壓看是凹陷性或非凹陷性）。
 - (6)評估病人評估呼吸音、呼吸狀況，是否出現呼吸困難、呼吸短促、端坐呼吸、囉音、肺積水等。
 - (7)教導正確深呼吸及咳嗽方法，避免肺部合併症的方法。
 - (8)病人呼吸困難時，給予抬高床頭 30-40 度採半坐臥姿勢以利呼吸。
 - (9)嚴重水腫時，臥床休息，增加心臟回流量，增加腎臟灌流以促進利尿作用。
 - (10)給予水腫部位提供適當的皮膚照顧，注意皮膚護理，在骨突處或易受壓處給予支托，注意是否有發紅及蒼白情形，避免皮膚受壓及過冷、過熱之情況，預防皮膚乾燥，可使用潤滑劑來潤濕皮膚，每兩小時協助臥床病人翻身以減輕受壓時間，移動病人時避免摩擦力的產生，並保持床單之平整以減少受壓及及促進舒適。

主題名稱	急性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/8

(11) 限制水份（每日液體攝入量為前一日尿量加上 500cc），並教導其重要性。

(12) 監測尿量、尿比重、尿中蛋白質及尿排出量，監測檢驗值。

(13) 採低鈉低鹽、高蛋白、高熱量飲食。

(14) 依醫囑給予藥物（如：利尿劑、肌肉收縮劑或血管擴張劑、抗凝劑）。

2. 焦慮感受／與自我概念受到威脅與不確定感有關

(1) 評估病人焦慮程度及主要原因。

(2) 與病人建立信任關係，引導病人說出焦慮原因。

(3) 對病人說話速度平靜緩慢，耐心傾聽病人主訴，尋找引起焦慮的原因。

(4) 安排舒適環境予詳細的環境介紹，鼓勵病人討論其感覺和害怕。

(5) 增加病人安全感，在做治療前給予詳細解釋。

(6) 注意評估病人焦慮改善狀態。

(7) 利用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧及冥想來減輕焦慮。

(8) 安排病人喜歡的環境，分散注意力，減輕焦慮，如：聽音樂、聊天。

(9) 常予探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。

(10) 請家屬陪伴並給予心理支持。

(11) 焦慮感持續無法改善，必要時依醫囑給予藥物治療（如：鎮靜、精神神經安定劑）。

（八）衛教指導

1. 飲食須知：給予高醣、低蛋白質、低鈉、低鉀飲食。應依醫師及營養師指示選擇合宜之飲食種類，蛋白質應多攝取動物性蛋白質，勿食用醃漬物以防食入過多之鹽份，青菜最好燙後食用，含鉀離子高之水果最好不要選用，如：香蕉、梨子、楊桃等。

2. 洗腎後注意事項：

(1) 注意體重的變化，每日記錄飲食量及尿量。

(2) 透析用導管（雙腔管或腹膜管）保持清潔，勿折到或拉扯出。

(3) 執行透析須攝取高生物價值之蛋白質（動物性蛋白質），如豬肉、牛肉、

主題名稱	急性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/8

(4) 魚肉，但避免植物性蛋白質，如豆類植物。

(5) 少尿期時注意勿喝太多水(1500-2000cc)，限制鹽類及高鉀食物（如：水果、生菜、濃湯）；利尿期時，則可放寬。急性腎衰竭是暫時性的腎衰竭，若能針對其原因治療，則可以恢復腎功能，不用再繼續透析。但其病情往往相當嚴重，死亡率極高，治療期間仍要相當小心。

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（一）黃俊德、吳明儒、陳呈旭(2020)．急性腎損傷：流行病學、臨床表現、診斷與病因、治療與預後．腎臟與透析，32 (1)，1-5。https://doi.org/10.6340/KD.

202003

_32(1).0005

（二）黃士婷、莊雅雯、游棟閔、陳呈旭(2020)．急性腎臟損傷之透析治療．腎臟與透析，32(1)，22-26。https://doi.org/10.6340/KD.202003_32(1).0005

（三）Rovin, B. H., Adler, S. G., Barrat, J. Bridoux, F., Burdge, K. A., Chan, T. M., Cook, H. T., Fervenza, F. C., Gibson, K. L., Glassock, R. J., Jayne, D. R.W., Jha, V. k., Liew, A., Liu, Z. H., Mejía-Vilet, J. M., Nester, C. M., Radhakrishnan, J. E., Rave, M. & Floege, J. (2021).Executive summary of the KDIGO 2021 Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney International.100(4)753-779. https://

主題名稱	急性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/8

doi.org/10.1016/j.kint.2021.05.015.

七、附件

(略)

主題名稱	急性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.31	2.1	1.醫護部改護理部。 2.說明內容部份修辭。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	3.2	1.第三項說明內容部份修辭。 2.第三項第(五)目之 8 新增透析治療內容。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	新增參考文獻資料於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.5	第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	急性腎衰竭	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.19	3.6	第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.7	1. NANDA 護理診斷更新為護理問題。 2. 內文參考文獻引用刪除。 3. 第六項參考資料修訂。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.10.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.02	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	